

Tp. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp tại Bệnh viện Từ Dũ Cơ Sở 2
Ngày 16 tháng 03 năm 2026

Ngày 16 tháng 03 năm 2026, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì buổi họp với ban điều hành, các khoa của Bệnh viện Từ Dũ Cơ Sở 2.

Sau khi các khoa phòng báo cáo tiến độ thực hiện và trao đổi, thảo luận với đại diện các khoa, ban điều hành, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện có kết luận, chỉ đạo thực hiện các công tác sau trước ngày 24.03.2026:

1. Đối với công tác Hành chính quản trị:

a. Phòng khám:

- Phục hồi chức năng (phòng điện):

+ HCQT + Điều dưỡng bố trí tăng thêm 3 giường

+ HCQT + Điều dưỡng bố trí lại rèm che phù hợp, đảm bảo sự riêng tư

+ HCQT + Điều dưỡng Bố trí lại giường kéo cột sống, máy tập đạp vị trí phòng khác thích hợp.

- Phòng Nội, Ngoại: Điều dưỡng + HCQT trang bị bàn điều phối luồng bệnh khám

- Vệ sinh (rác, tàn thuốc lá), làm sạch cỏ và cây đại 2 bồn cây Vạn Thiên Tuế trước phòng khám và Cấp cứu. Gắn biển nhỏ cấm thuốc lá và không xả rác ở 4 bồn cây này.

- Đồng phục: Điều dưỡng + HCQT + VTTBYT thông báo nhân sự hỗ trợ điều phối mặc áo sơ mi trắng và mang thẻ nhân viên đúng quy định (đặc biệt bảo vệ, bảo trì,...)

- HCQT + Điều dưỡng tăng cường xe lăn tại phòng khám, để ưu tiên cho người lớn tuổi.

- Làm lại các bảng hướng dẫn lối đi, khu vực trong phòng khám bị sai thông tin, không chính xác.

- HCQT + VTTBYT + KHTH + Điều dưỡng di dời phòng khám Mắt + Răng hàm mặt + Tai mũi họng xuống tầng trệt.

- HCQT kiểm tra, đảm bảo hoạt động và khóa thang máy C2 khu C (cuối dãy khoa Sản)

- HCQT đánh số phòng các khu đang hoạt động hoạt động (phòng khám, Cấp cứu, Nội, Ngoại, XN, Xquang, Thận Nhân Tạo) (nhắc lại lần 4)

- HCQT rà soát và khóa các khu vực không hoạt động, đảm bảo an ninh không để người không phận sự vào.

- HCQT + VTTBYT rà soát, kiểm đếm, báo cáo danh sách chi tiết các thiết bị Inox ở các khu vực trong bệnh viện.

- Khoa Sản:

+ Điều dưỡng + HCQT rà soát, điều chỉnh kê nhiều nhất 2 giường trong 1 phòng.

- + HCQT sửa cửa ra vào khoa Sản thành cửa có thể khóa.
- + Chuyển đổi công năng phòng khám thành phòng hậu sản.
- Khu vực tiếp nhận TTCC115 (ở Cấp cứu): làm bảng mica để bàn “Tạm Ngưng” trong lúc TTCC115 đi ngoại viện
- Khu vực Hồi sức tại khoa Cấp cứu:
 - + HCQT + Điều dưỡng làm lại hệ thống rèm để tăng tính riêng tư người bệnh nam và nữ.
 - + HCQT + KHTH + Điều dưỡng triển khai phòng lưu, lưu ý thanh toán BHYT
- b. Xét nghiệm:
 - HCQT trang bị rèm vào thứ 5, 19.03.2026
 - XN + HCQT điều chuyển tủ lạnh về cùng 1 vị trí vào thứ 5, 19.03.2026.

2. Đối với công tác chuyên môn:

- a. Công tác nâng cao chất lượng điều trị
 - KHTH trong 24 giờ phải triển khai sổ sức khỏe điện tử (bệnh nhân khám không quá 3 lần phải khám đủ các chuyên khoa để tầm soát toàn diện và có sổ sức khỏe điện tử)
 - KHTH tổ chức bình bệnh án, bình đơn thuốc tất cả các ca chuyển viện (phân tích nguyên nhân gốc).
 - KHTH triển khai đối với nội trú:
 - + Xây dựng và giám sát tiêu chuẩn nhập viện
 - + Giám sát tuân thủ phác đồ điều trị
 - + Triển khai khám toàn diện các chuyên khoa trước khi xuất viện, triển khai sổ sức khỏe nội trú.
- b. Triển khai quy trình/ danh mục mới:
 - KHTH + Điều Dưỡng triển khai 100% khám sức khỏe toàn diện vào 01/04/2026. Thông báo giao ban, báo cáo triển khai cho BGĐ mỗi tuần.
 - KHTH + TCKT triển khai giảm đau sản khoa (để không đau) được thanh toán BHYT.
 - KHTH triển khai Nội soi TMH và Nội Soi tiêu hóa trên, dưới. HCQT+ VTTBYT triển khai cơ sở vật chất và trang thiết bị
- c. Công tác báo cáo
 - Xây dựng KH và báo cáo công tác để triển khai 50 - 100 giường bệnh nội trú
 - KHTH báo cáo số lượng danh mục kỹ thuật đã thực hiện trong tuần.
 - KHTH báo cáo số lượng ca triển khai sổ sức khỏe từng loại phòng khám.
 - KHTH báo cáo các ca chuyển viện ca nào theo yêu cầu, ca nào chuyển theo chuyên môn ?

- KHTH và Cấp cứu báo cáo các ca bệnh nặng, bệnh nặng xin về
- KHTH báo cáo, phân tích các chỉ định CLS, bóc tách chi tiết CLS.

d. Nội trú:

- KHTH + TCCB xây dựng quy định nhập viện của từng chuyên khoa:
- + Trường hợp nào cần theo dõi
- + Trường hợp điều trị nội trú có tuân thủ phát đồ điều trị
- + Khám toàn diện triển khai như thế nào
- + Trong 48 giờ tổ chức thực hiện báo cáo gấp.
- KHTH có kế hoạch đào tạo BSGMHS: khám nội, các bệnh không lây, tiểu đường, tăng huyết áp.

e. Công tác chỉ đạo tuyến:

- KHTH + CĐT lên KH làm việc với 4 lãnh đạo xã và trạm y tế ở Cần Giò, gửi báo cáo BGD vào ngày 20/03/2026
- KHTH + CĐT + TCCB tổ chức gặp mặt trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo và trạm y tế với BGD để ký các MOU vào 23/03/2026

f. Chuyển tuyến:

- Các ca chuyển viện, KHTH cho ký phiếu cam kết của BN đã được tư vấn: thiết bị, thuốc, trình độ chuyên môn cao của bác sĩ nhưng người bệnh vẫn muốn chuyển.

3. Đối với công tác quản lý khác:

a. Công tác điều phối bệnh:

- Rà soát vị trí, bố trí khu vực tiếp nhận, xếp hàng, đóng tiền không để ùn ứ và sử dụng hiệu quả, tinh – gọn nguồn lực.
- Rà soát tốc độ điều phối bệnh vào các phòng khám khi lượng bệnh đông (phòng khám ít bệnh ưu tiên tiếp nhận, phòng khám đông bệnh tốc độ tiếp nhận chậm lại)
- Điều dưỡng rà soát chỉ để tối đa 2 bệnh nhân trong 1 phòng khám nội và khám ngoại
- KHTH + Điều Dưỡng mở phòng khám Nội 3 vào thứ 2, thứ 3 và thời điểm đông bệnh.

b. Công tác quản lý khác:

- HCQT thực hành tiết kiệm: kiểm tra, rà soát chỉ số điện nước mỗi ngày. Kiểm tra điện nước các khu vực không hoạt động.
- HCQT giám sát việc sử dụng tiết kiệm máy lạnh tại khu vực nhà nghỉ nhân viên, nên sử dụng máy lạnh vào buổi trưa, còn các buổi khác sử dụng khí trời để thông thoáng phòng.
- HCQT giám sát chặt các nhân sự thuê ngoài (làm sạch và Thanh niên xung phong) và TTCC115:

+ Giám sát nhân sự đếm danh FaceID theo đúng quy định đối với nhân viên bệnh viện.

+ Giám sát số lượng người ca sáng và ca đêm

+ Giám sát vị trí việc làm của nhân sự

+ Giám sát vị trí tập kết, làm việc, nghỉ ngơi. Các nơi này cần quy hoạch thành khu vực tập trung, không rải rác nơi tập kết dụng cụ, nghỉ ngơi ở các khoa.

+ Người quản lý ca, số điện thoại liên hệ

- HCQT dán nội quy phòng khám, nội quy phòng nghỉ nhân viên

- KHTH + Điều dưỡng giám sát hoạt động (nội trú, ngoại trú, cấp cứu, thận nhân tạo) và nâng cao chất lượng điều trị và uy tín của bệnh viện. TCCB + HCQT đếm danh

- TCCB xây dựng lịch trực đêm Ban điều hành CS2 mỗi tuần.

- TCCB + KHTH + Điều Dưỡng đánh giá, xây dựng phương án nhân sự sau 3 tháng hoạt động CS2

- TCCB + TCKT rà soát lại tiền nhân công (chính sách, vị trí việc làm phù hợp với công việc ở CS2)

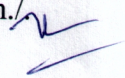
- KSNK + HCQT giám sát và báo cáo công tác xử lý nước thải

c. Xét nghiệm:

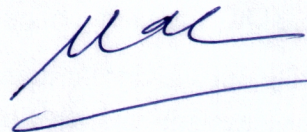
- CNTT + XN kết nối các cổng máy XN vào 1 máy tính.

- Báo cáo tuần phân tích chi tiết các nhóm xét nghiệm theo phòng khám, khoa, trong đó những xét nghiệm làm tại BVTĐ CS2, xét nghiệm làm tại BVTĐ CS1

- Điều dưỡng + HCQT di chuyển XN lấy máu tại tầng trệt (chú ý ghế ngồi cho NB) vào thứ 5, ngày 19.03.2026.

Phòng KHTH thông báo Kết luận của Giám đốc để các khoa phòng liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện. 

GIÁM ĐỐC



BS CKII Trần Ngọc Hải